PLAN POSTĘPOWANIA — SPRAWA NAWROTU TORBIELI I KONTROLI CBCT

Stan planu: 13.10.2026 **Status sprawy:** dokumentacja i porównanie badań do zebrania. Na tym etapie nie przesądzamy, czy nawrót był widoczny 04.08.2026 ani czy doszło do błędu.

Ta lista jest roboczym planem dla pacjentki. Zaznaczaj zadania dopiero po ich wykonaniu i zapisuj datę wysłania lub otrzymania dokumentu. Nie odkładaj zaleconego leczenia w oczekiwaniu na dokumentację lub opinię.

A. Teraz — leczenie, dokumenty i zabezpieczenie dowodów

- [ ] **Potwierdzić dalszy przebieg leczenia w Gabinecie nr 2.** Czy ponowna resekcja i wyłuszczenie torbieli już się odbyły? Jeśli tak, zapisać datę i uzyskać dokumentację zabiegu, zalecenia, recepty, rachunki oraz wynik badania histopatologicznego, jeśli materiał wysłano do badania.
- [ ] Wysłać do **Gabinetu nr 1** wniosek o całą dokumentację dotyczącą leczenia okolicy zębów 11 i 12: dokumentację zabiegu z 14.01.2021, kontrole, wpis z 04.08.2026, zalecenia, opisy badań, nazwiska osób badających/opisujących oraz dostępne pliki CBCT/DICOM z 2020/2021, 2023 i 04.08.2026.
- [ ] W tym samym piśmie poprosić Gabinet nr 1 o informacje o umowie OC obejmującej wizytę 04.08.2026: ubezpieczyciel, numer i okres polisy oraz suma gwarancyjna.
- [ ] Wysłać do **Gabinetu nr 2** osobny wniosek o dokumentację wizyty 25.09.2026: badanie, rozpoznanie ropnia i nawrotu, zapis nacięcia ropnia, receptę, opis CBCT i dostępny DICOM, plan/kosztorys oraz późniejszą dokumentację leczenia.
- [ ] Zachować dowód złożenia każdego wniosku i odnotować datę doręczenia. Pierwsze udostępnienie dokumentacji w zakresie i formach wskazanych w art. 28 ust. 2a jest bezpłatne; dokumentację udostępnia się bez zbędnej zwłoki. Nie ma ogólnego ustawowego terminu 14 dni roboczych.
- [ ] Zachować w niezmienionej postaci wszystkie oryginalne pliki obrazowe, płyty i dokumenty. Zrobić kopię zapasową, ale nie nadpisywać źródłowych plików DICOM.
- [ ] Prowadzić krótką chronologię objawów i leczenia: daty, obrzęk, ból (jeśli występował), leki, wizyty i zalecenia. Zachować zdjęcia z datami, rachunki za badania, leczenie, leki i dojazdy.

B. Po otrzymaniu dokumentacji — ustalenie, co pokazują badania

- [ ] Sprawdzić, czy Gabinet nr 1 ma wpis z 04.08.2026, pisemny opis CBCT i zalecenie kontroli za rok. Zanotować, kto wykonał badanie, kto je ocenił i co zapisano.
- [ ] Sprawdzić, czy uzyskano kompletne badania CBCT w formacie umożliwiającym porównanie, zwłaszcza z 04.08.2026 i 25.09.2026. Uzupełnić wcześniejsze badanie z 2023 r., jeśli jest dostępne.
- [ ] Poprosić lekarza z odpowiednimi kwalifikacjami lub niezależnego specjalistę o osobną pisemną

ocenę porównawczą. Pytania do oceny: czy zmiana była widoczna 04.08.2026, czy wymagała wtedy dalszej diagnostyki/leczenia i czy opóźnienie mogło wpłynąć na ropień, dolegliwości, zakres leczenia albo koszty.

- [ ] Poprosić Gabinet nr 2 o plan leczenia i kosztorys na piśmie oraz dokumentację faktycznie wykonanych procedur. Prośba o sporządzenie nowej opinii jest odrębna od prawa do otrzymania istniejącej dokumentacji.
- [ ] W razie rozbieżności między opisem, wpisem a ustną informacją poprosić placówkę o wyjaśnienie na piśmie. Nie poprawiać ani nie uzupełniać samodzielnie dokumentacji medycznej.

C. Po wstępnej ocenie dowodów — przygotowanie roszczenia

- [ ] Ustalić, kto udzielał świadczenia 04.08.2026 i kto powinien być adresatem roszczenia: ubezpieczyciel, podmiot leczniczy, lekarz lub właściwe podmioty. Sama praca w gabinecie nie przesądza automatycznie, kto odpowiada.
- [ ] Sporządzić krótką tabelę kosztów: data, wydatek, kwota, dowód zapłaty i związek z leczeniem. Oddzielić poniesione koszty od planowanych.
- [ ] Ustalić, które następstwa można powiązać z opóźnionym rozpoznaniem. Nie zakładać automatycznie, że cały koszt leczenia nawrotu powstał przez wizytę z 04.08.2026.
- [ ] Uzupełnić projekt zgłoszenia szkody faktami potwierdzonymi dokumentami. Opisać ocenę z 04.08 jako ustny przekaz, jeżeli nie ma jej w karcie. Kwestie sporne przedstawić jako zarzuty/wnioski do zbadania, a nie jako ustalone fakty.
- [ ] Dołączyć dokumentację, porównanie CBCT, rachunki, plan i kosztorys leczenia oraz dowody dolegliwości — wyłącznie w zakresie, który rzeczywiście dotyczy pacjentki.
- [ ] Jeśli nie ma jeszcze wszystkich dokumentów, można rozważyć zgłoszenie szkody i późniejsze uzupełnienie materiału; zachować potwierdzenie doręczenia. Art. 819 § 4 KC dotyczy przerwania biegu przedawnienia roszczenia wobec ubezpieczyciela, nie należy traktować go jako automatycznego zabezpieczenia wszystkich roszczeń wobec innych podmiotów.

D. Po odpowiedzi ubezpieczyciela lub placówki

- [ ] Zachować decyzję, uzasadnienie, korespondencję i datę jej otrzymania.
- [ ] Sprawdzić, czy ubezpieczyciel odniósł się do każdego dowodu i wypłacił ewentualną część bezsporną. Termin 30 dni nie oznacza bezwarunkowej wypłaty całej żądanej kwoty; ustawa przewiduje też sytuacje, w których ustalenie odpowiedzialności lub kwoty trwa dłużej.
- [ ] W razie odmowy lub sporu co do przyczynowości uzupełnić dowody i rozważyć konsultację z adwokatem/radcą prawnym. Rzecznik Finansowy może być właściwy po przejściu procedury reklamacyjnej u ubezpieczyciela.
- [ ] Daty przedawnienia ustalać na podstawie konkretnych faktów i rodzaju roszczenia; nie przyjmować z góry, że termin zawsze zaczyna się w dniu wizyty weryfikacyjnej.

E. Rejestr korespondencji

Data	Do kogo	Pismo / dokument	Sposób wysłania	Potwierdzenie / odpowiedź
	Gabinet nr 1	Dokumentacja + dane OC		
	Gabinet nr 2	Dokumentacja wizyty i leczenia		
	Lekarz/specjalista	Prośba o porównanie CBCT		
	Ubezpieczyciel	Zgłoszenie szkody		

Dokumenty w repozytorium

- Poradnik sprawy — strona HTML
- Historia pacjentki
- Wniosek o dokumentację i dane OC
- Robocze zgłoszenie szkody
- Ogólny szablon zgłoszenia szkody

Podstawy prawne — teksty oficjalne

- Ustawa o prawach pacjenta — Dz.U. 2024 poz. 581
- Ustawa o działalności leczniczej — t.j. Dz.U. 2026 poz. 156
- Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych — t.j. Dz.U. 2026 poz. 783
- Kodeks cywilny — t.j. Dz.U. 2026 poz. 795
- Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty — t.j. Dz.U. 2026 poz. 37

Plan jest pomocą organizacyjną, nie poradą prawną ani medyczną. Zmiany stanu sprawy dopisuj z datą i źródłem informacji.